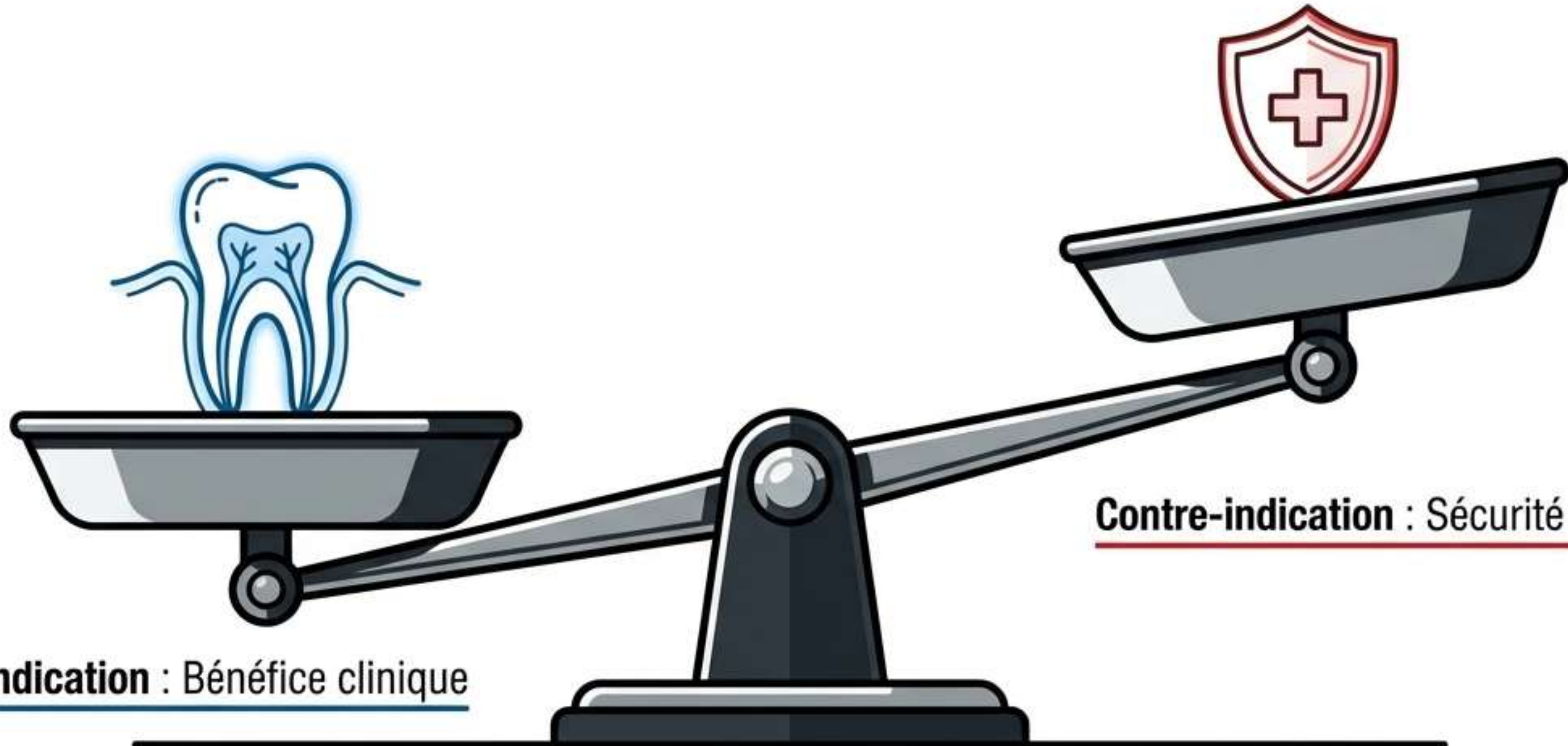




INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS DES EXTRACTIONS DENTAIRES (L'Avulsion Dentaire)

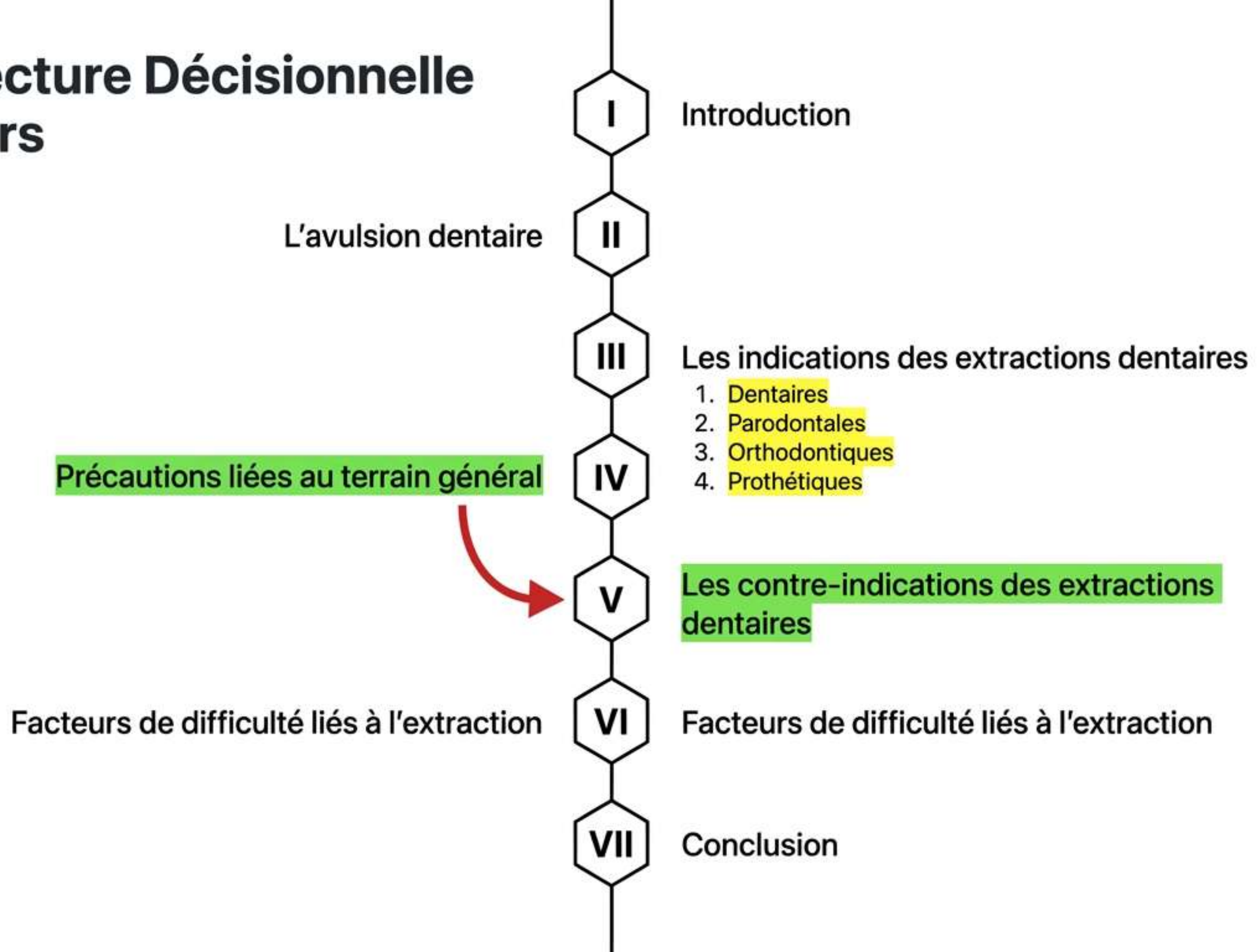
Cours de Pathologie - 2^{ème} Année | Présenté par Dr Messaoudi | Année universitaire 2025-2026



Indication : Bénéfice clinique

Contre-indication : Sécurité du patient

Architecture Décisionnelle du Cours



I & II. Fondements et Objectifs de l'Avulsion Dentaire

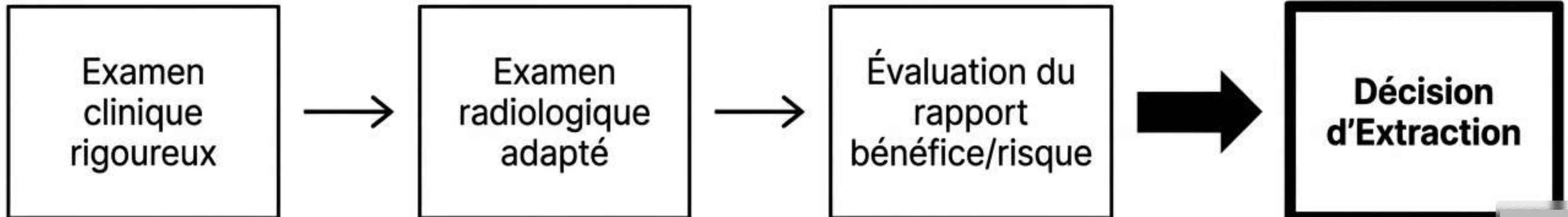
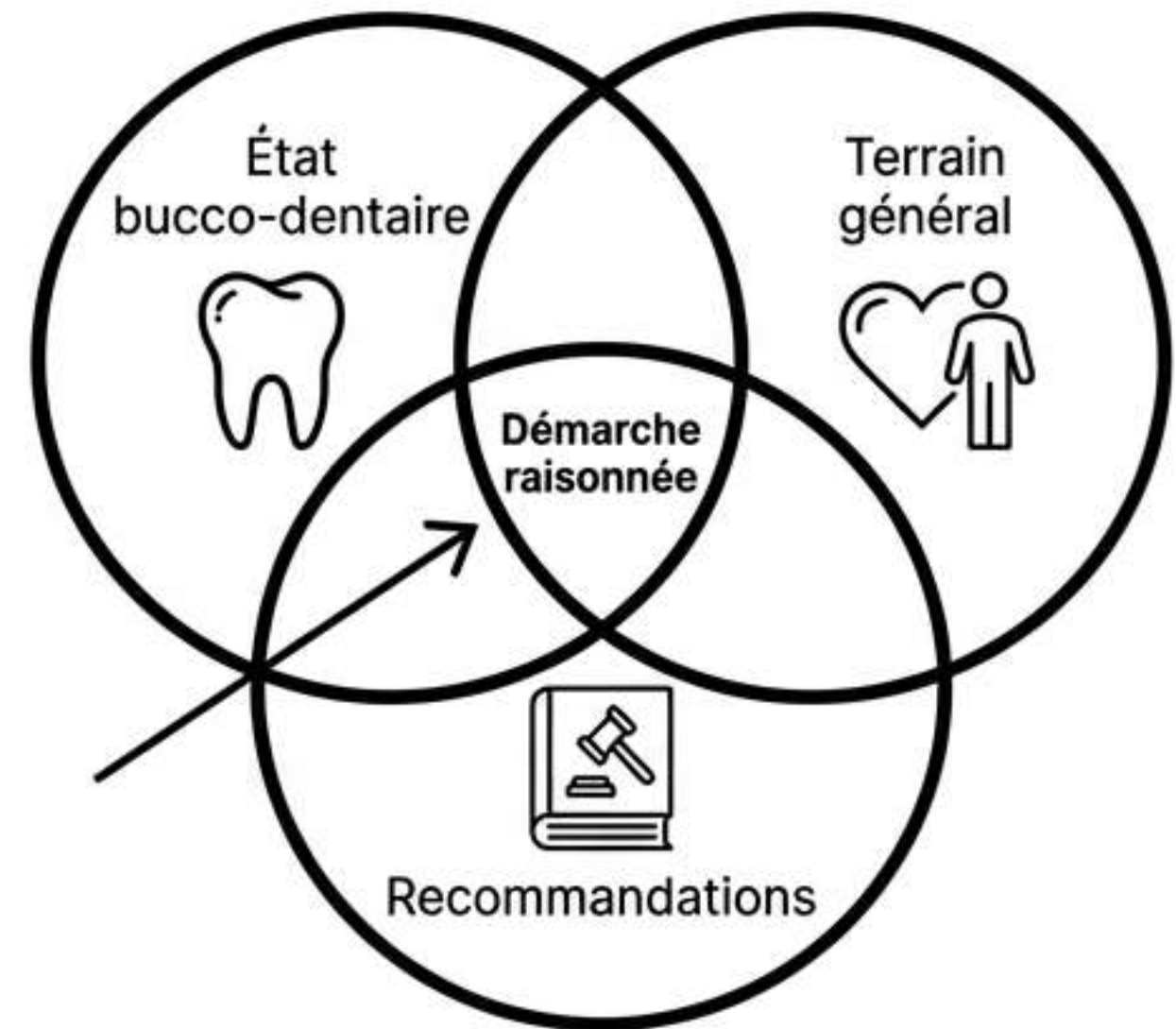
Contexte : Acte chirurgical ancien et fréquent. Malgré les progrès (conservatrice, endodontie, parodontologie), l'avulsion reste parfois la seule option.

Cet acte ne doit jamais être banalisé [Predicted – Concept éthique fondamental]

Définition : Retirer une dent (temporaire ou permanente) de son alvéole (simple ou chirurgicale).

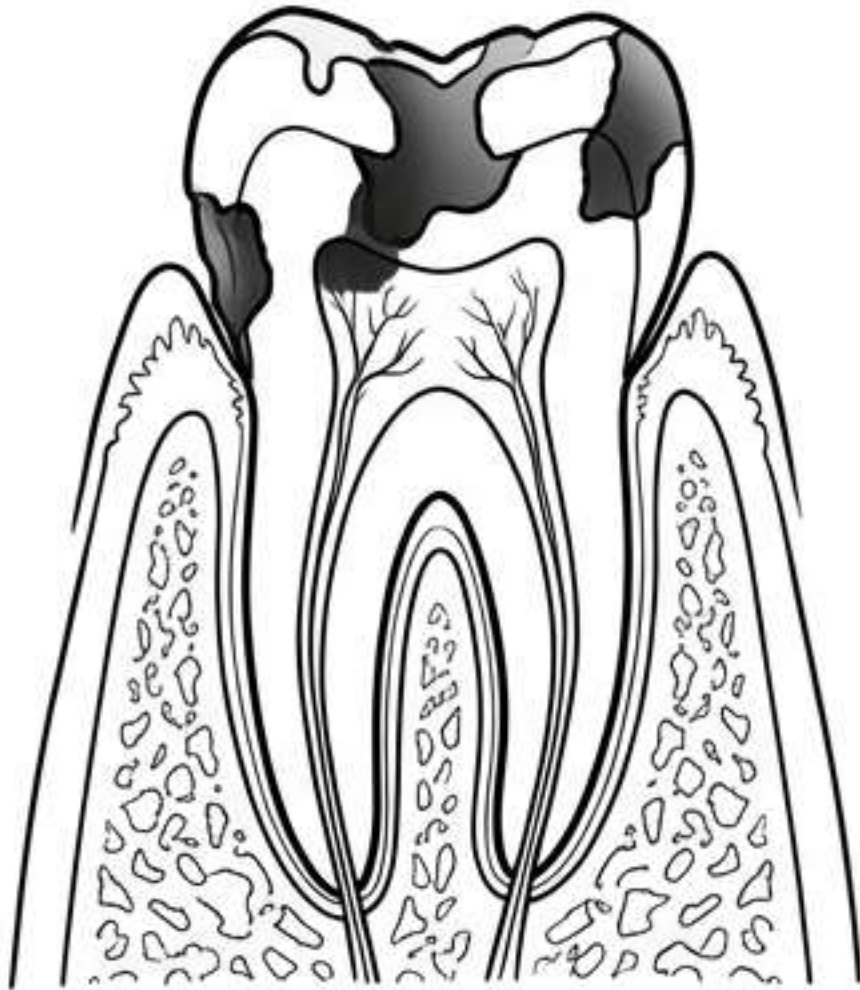
- ✓ - Supprimer infection/douleur.
- ✓ - Prévenir la propagation (locale/générale).
- ✓ - Faciliter un traitement ortho/prothétique.
- ✓ - Améliorer la santé bucco-dentaire globale.

Stratégie thérapeutique globale



III. 1. Indications Dentaires : Dents Irrémédiablement Compromises

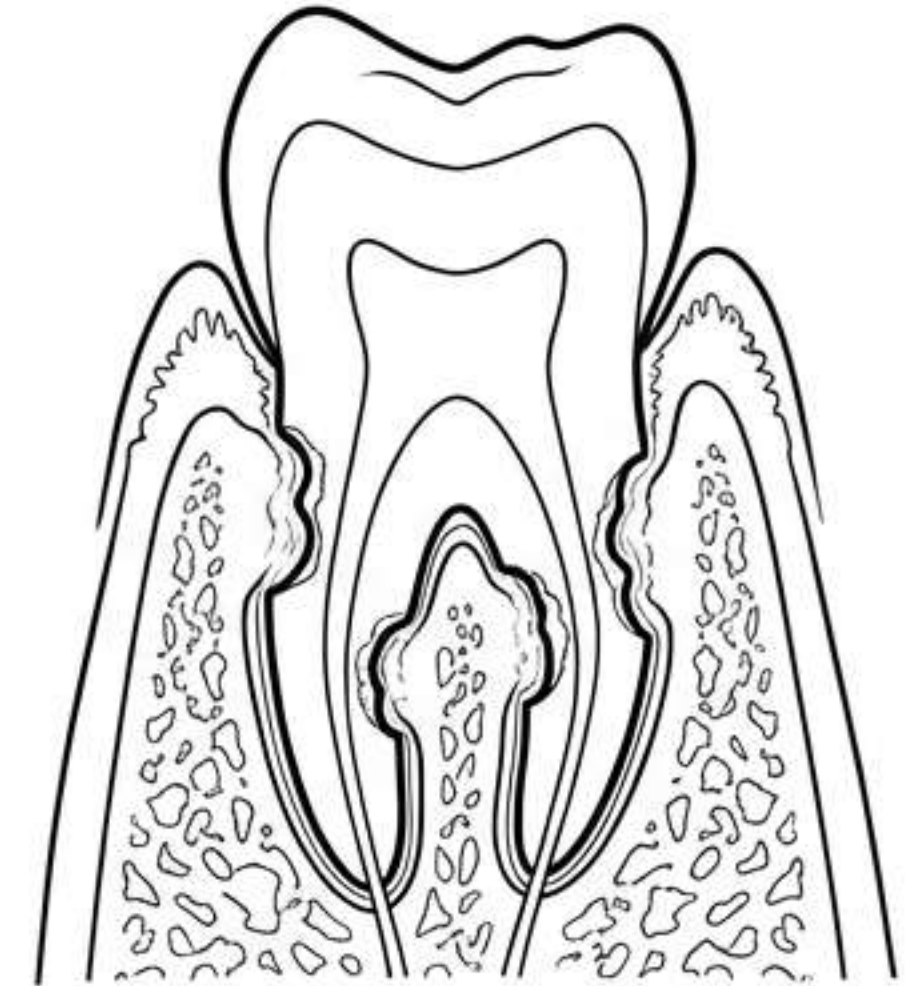
- Caries étendues et profondes non restaurables.
- Dents délabrées avec destruction coronaire majeure.
- Échec des traitements conservateurs ou endodontiques.
- **Fractures coronaires ou radiculaires irréparables** [Ref: Q3 (2021 EMD)]
- **Dents atteintes de résorptions radiculaires internes ou externes sévères** [Ref: Q11 (2024 EMD), Q19 (2023 EMD)]



Destruction coronaire majeure
& Caries non restaurables



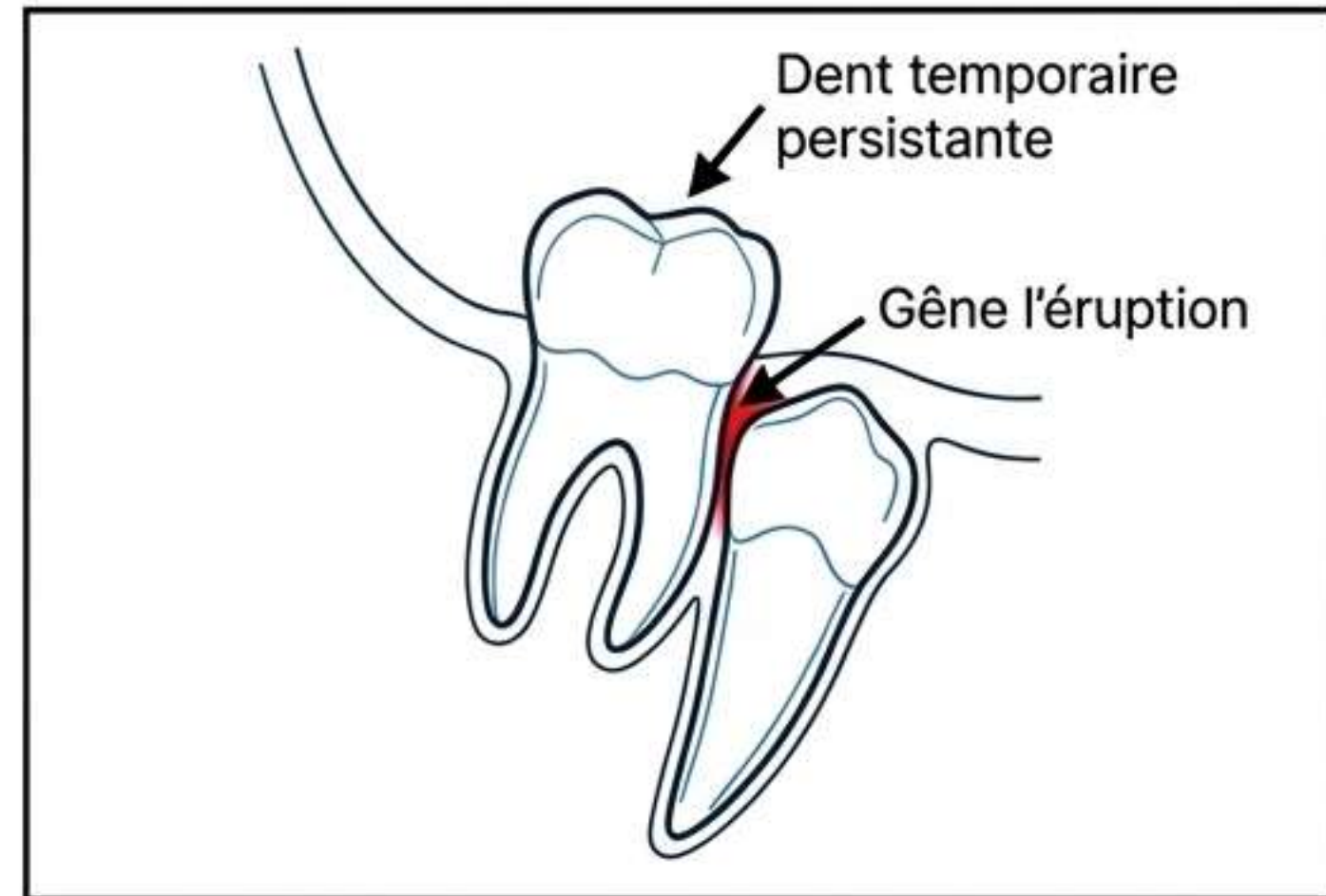
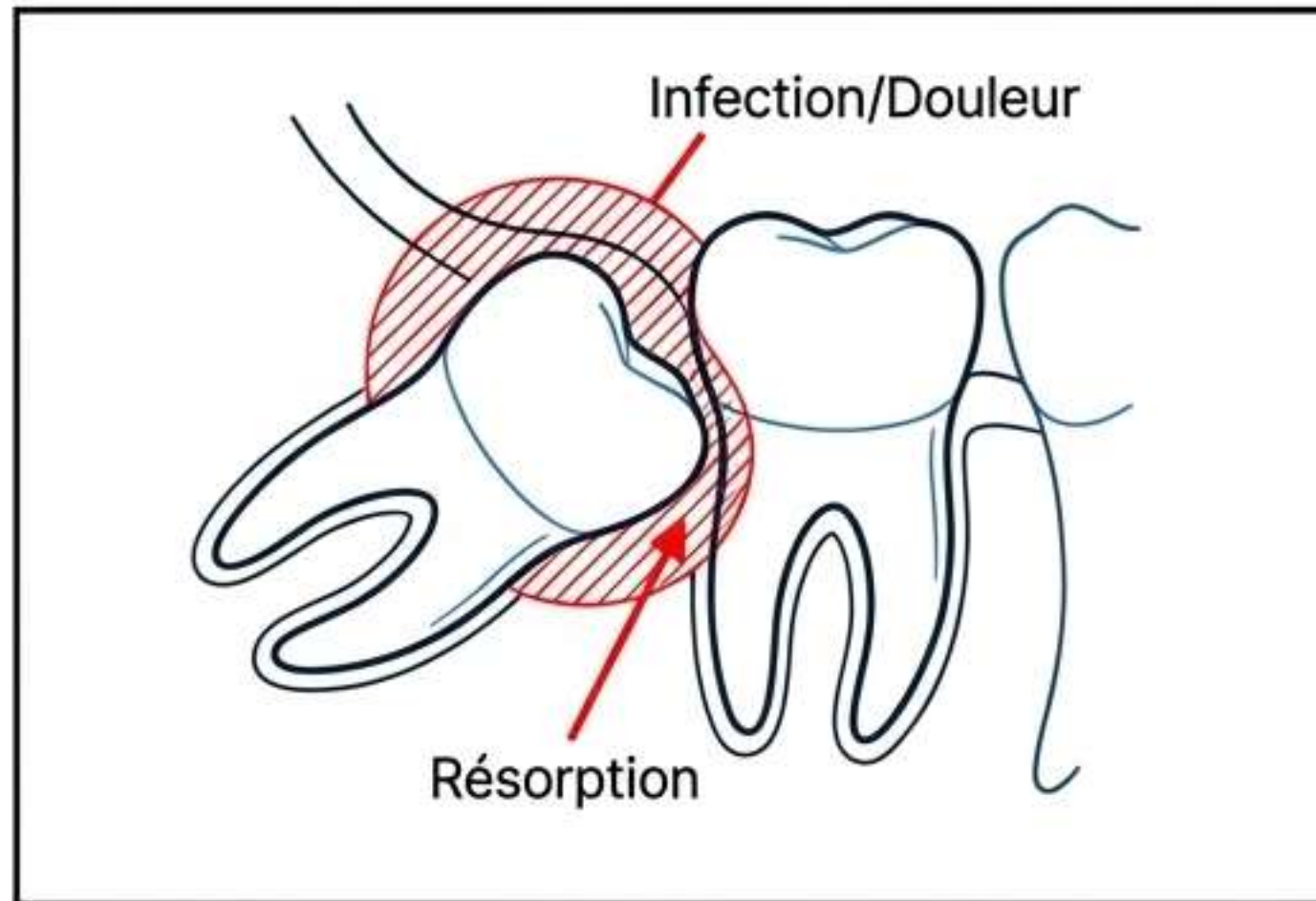
Fracture radiculaire
irréparable



Résorption radiculaire sévère

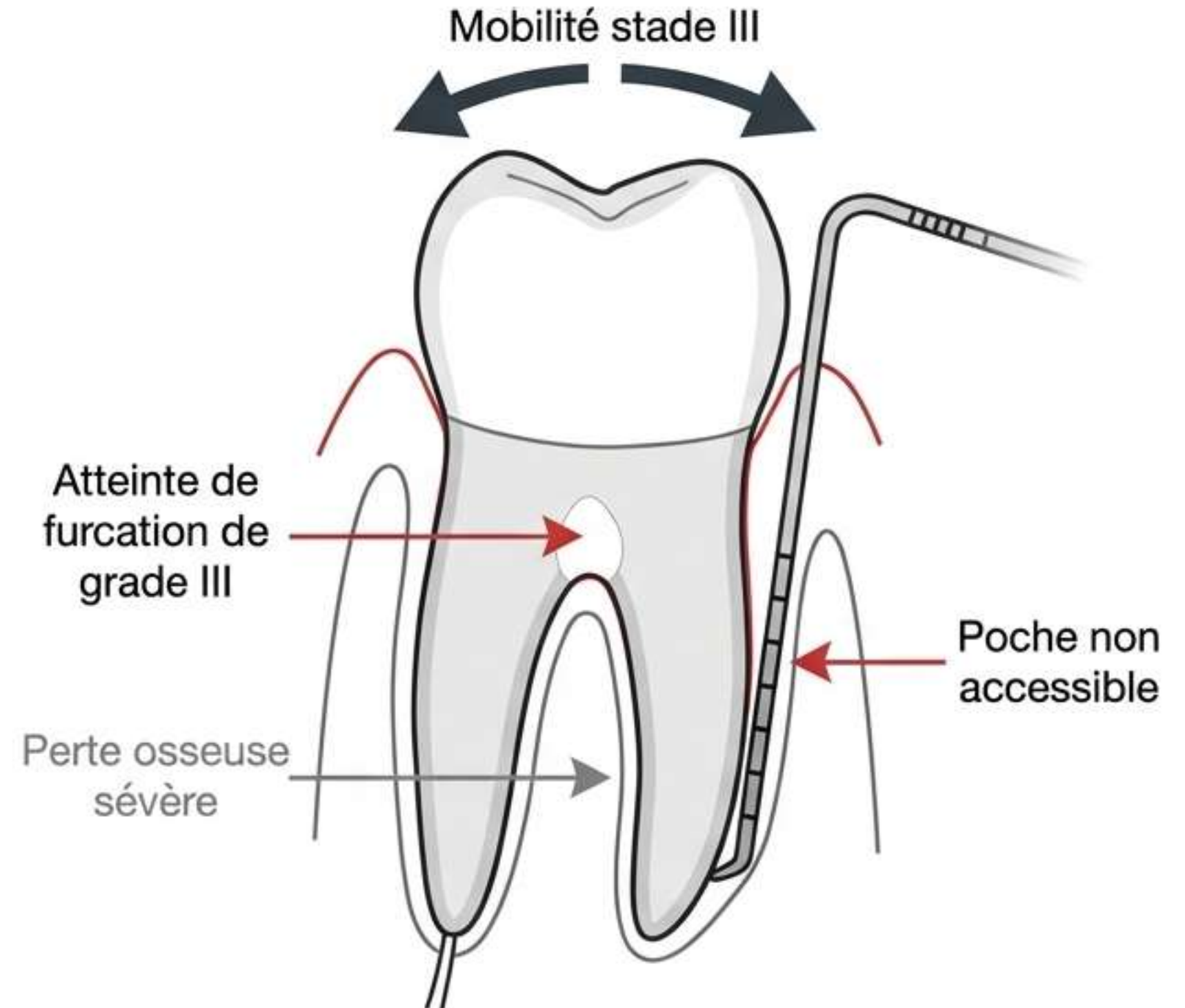
III. 1. Indications Dentaires : Complications et Odontologie Pédiatrique

- Dents incluses ou enclavées associées à des complications (infection, douleur, résorption des dents adjacentes) [Ref: Q14 (2021 EMD), Q19 (2021 EMD), Q12 (2023 EMD)]
- Dents responsables d'abcès aigus ou chroniques récidivants [Ref: Q3 (2021 EMD), Q14 (2024 RATT)]
- Dents temporaires persistantes sans successeur ou gênant l'éruption de la dent permanente [Ref: Q14 (2021 EMD), Q8 (2022 EMD)]



III. 2. Indications Parodontales : Atteintes du Support

- Mobilité dentaire avancée (stade III) [Ref: Q5 (2019 EMD)]
- Perte osseuse sévère compromettant la stabilité de la dent [Ref: Q5 (2019 EMD)]
- Atteinte de furcation de grade III [Ref: Q3 (2021 EMD)]
- Poches parodontales profondes non accessibles au traitement.
- Dents responsables de foyers infectieux parodontaux persistants.
- Dents gênant l'assainissement parodontal global.



III. 3. Indications Orthodontiques : Alignement et Occlusion

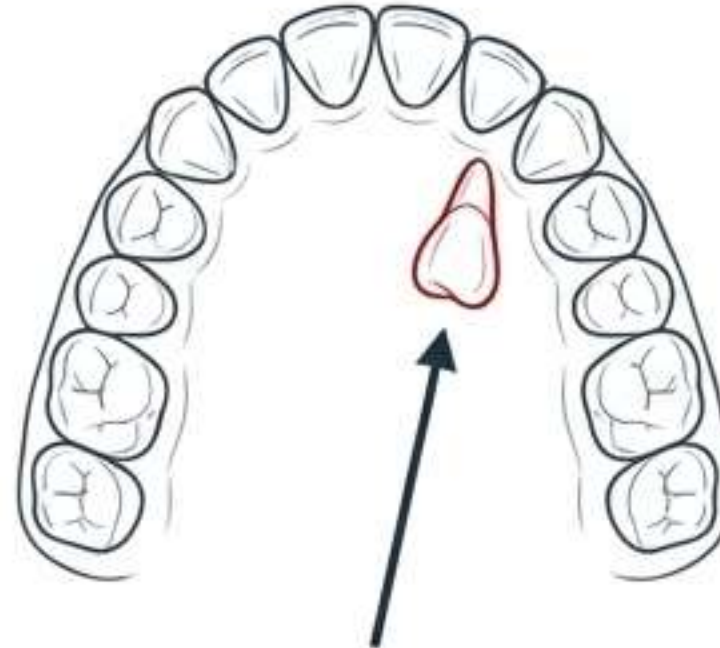
- Encombrement dentaire sévère.
- Dysharmonie dento-maxillaire.
- Dents surnuméraires.
- Dents mal positionnées ou ectopiques [Ref: Q11 (2023 RATT)]
- Préparation orthodontique pré-chirurgicale.
- Extraction de dents temporaires dans le cadre d'un guidage d'éruption [Ref: Q8 (2022 EMD)]

Espace



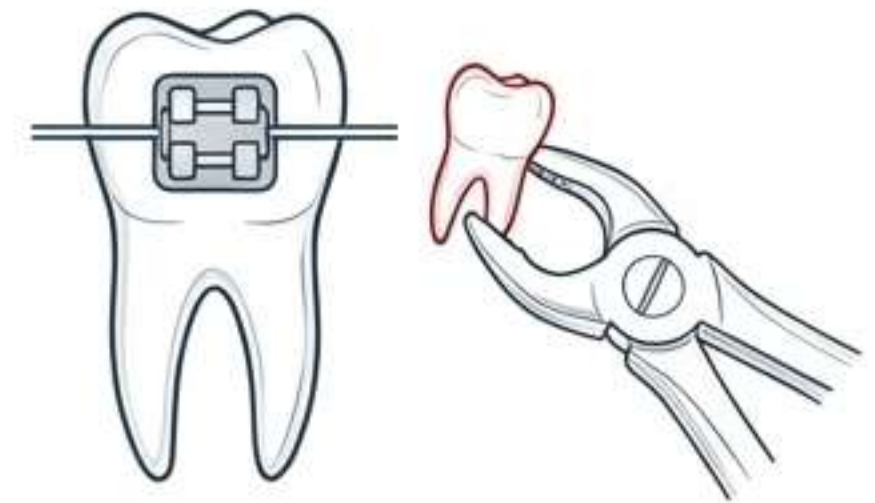
Encombrement sévère /
Dysharmonie

Position



Dent ectopique : au maxillaire
mais éloignée du site normal

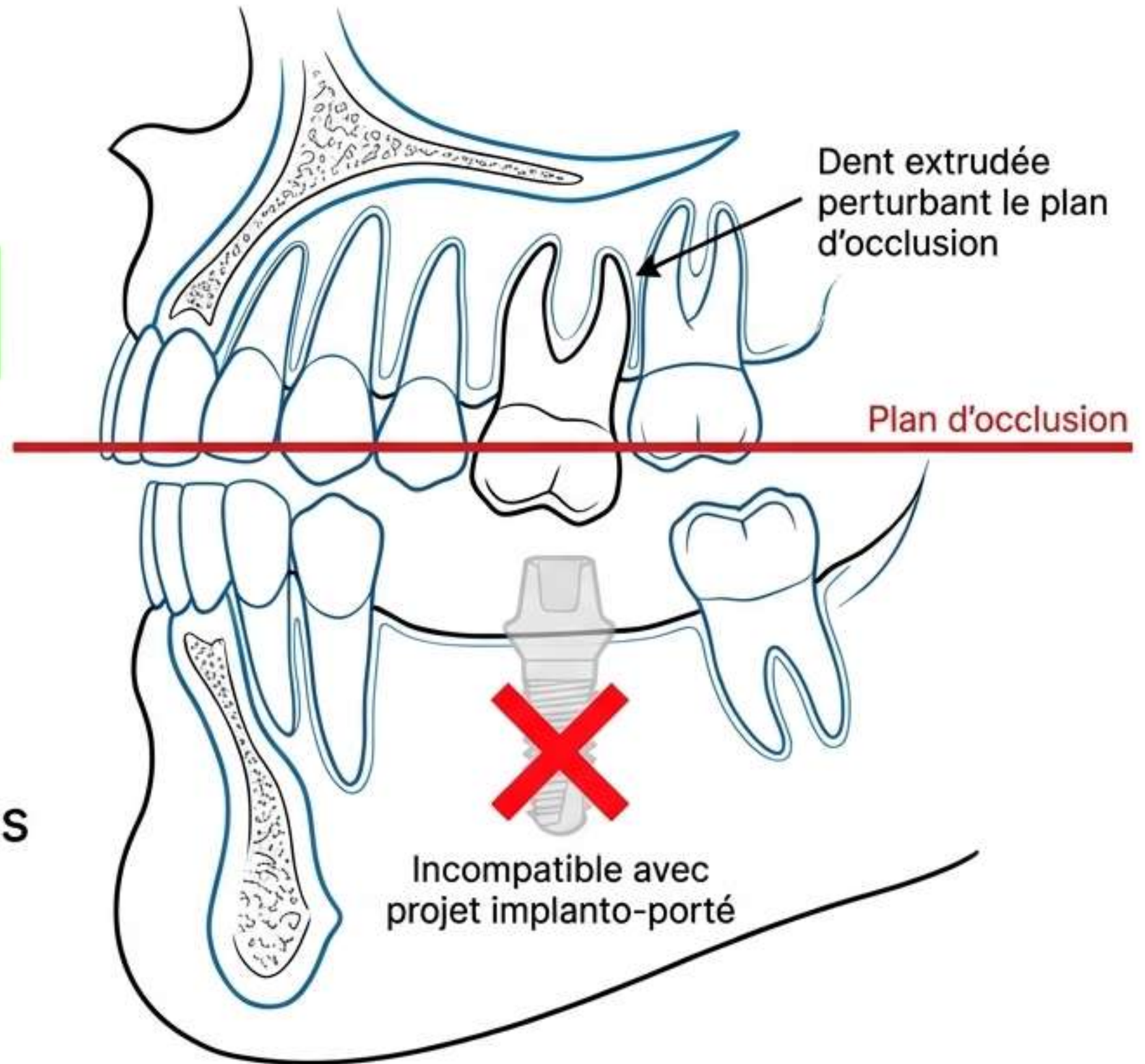
Intervention



Préparation pré-chirurgicale
& Guidage d'éruption

III. 4. Indications Prothétiques : Cohérence du Projet

- Dents à mauvais pronostic compromettant une future prothèse.
- Dents extrudées ou migrées perturbant le plan d'occlusion
[Predicted – Mécanisme prothétique souvent oublié]
- Dents incompatibles avec un projet implanto-porté.
- Racines résiduelles.
- Dents support de prothèse insuffisantes ou pathologiques.



IV. Précautions liées au terrain général (Cardiaque, Osseux, Métabolique)

Avant toute extraction, une attention particulière doit être portée au terrain du patient : SF Pro Text



Patients cardiopathes :

Évaluation du risque infectieux, adaptation de l'anesthésie/prise en charge.

prévention de l'endocardite infectieuse selon les recommandations [Ref : Q14 (2022 EMD)]



Anti-résorptifs (bisphosphonates, denosumab) :

Indication d'extraction strictement posée, concertation médicale indispensable.

Risque d'ostéonécrose des maxillaires [Predicted – Incidence clinique critique]



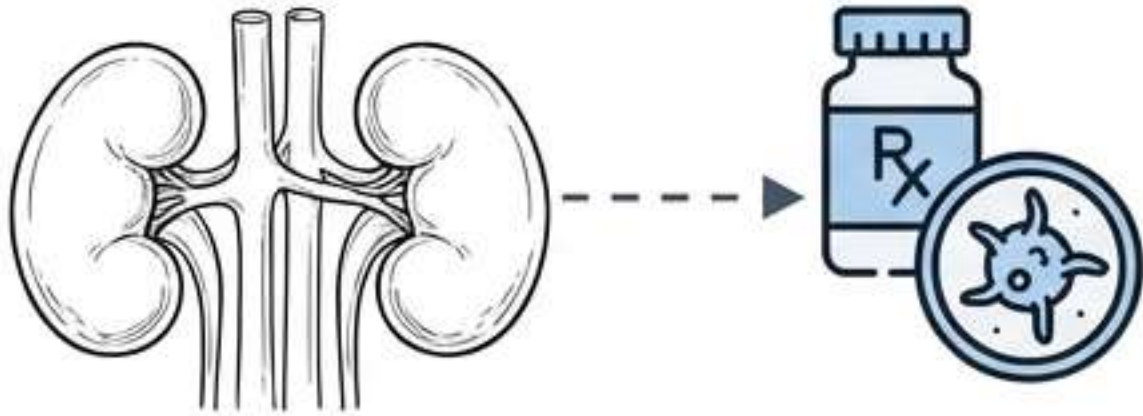
Patients diabétiques :

Contrôle glycémique préalable.

risque infectieux accru, retard de cicatrisation [Ref: Q19 (2021 EMD)]

IV. Précautions liées au terrain général (Rénal et Hémostasie)

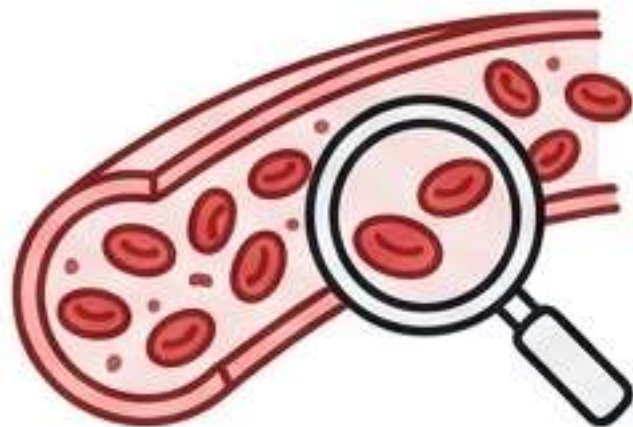
Renal Focus



Patients insuffisants rénaux : Adaptation des prescriptions médicamenteuses.

prise en compte des troubles de l'hémostasie [Predicted – Souvent confondu avec d'autres pathologies]

Hemostasis Focus

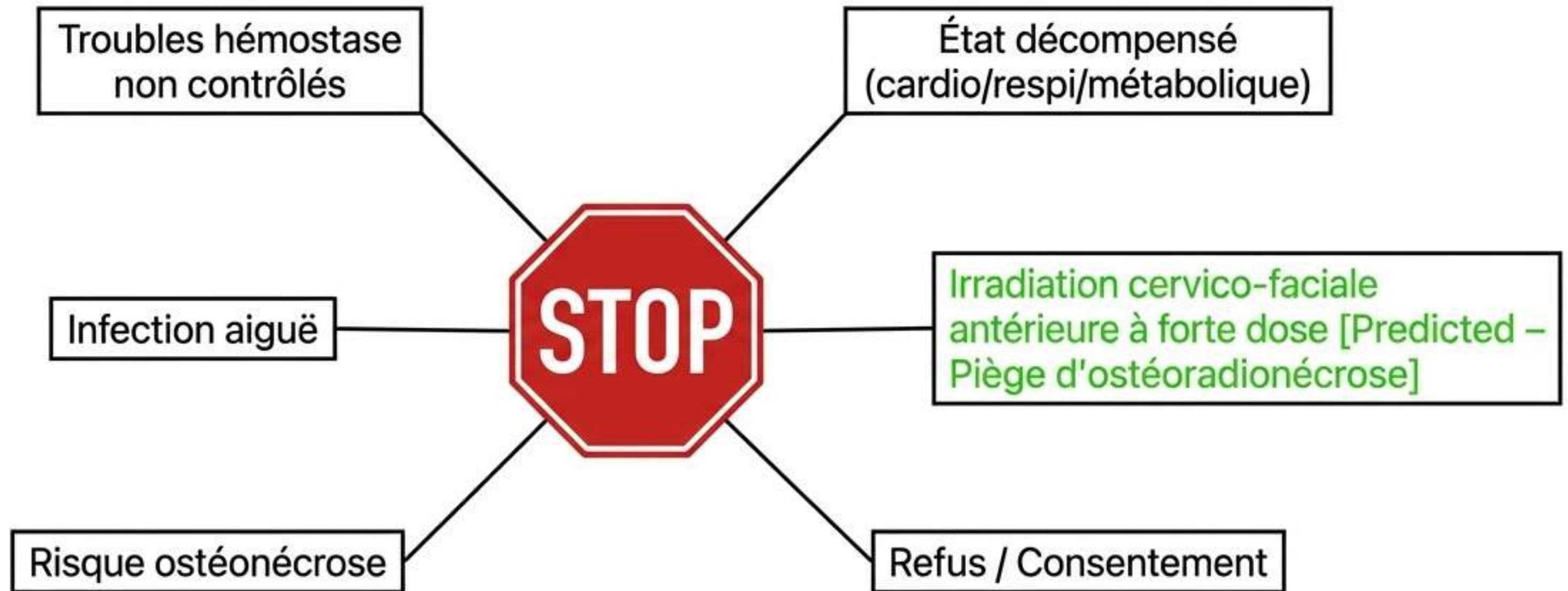


Patients sous traitement anticoagulant ou antiagrégant :

Évaluation du risque hémorragique et respect des protocoles recommandés [Ref: Q18 (2019 EMD), Q4 (2018 Synthèse), Q3 (2023 EMD), Q10 (2022 EMD)]

(Note: Exams frequently test INR 2-4 parameters here).

V. Les Contre-Indications des Extractions Dentaires



Action (CI Relatives) : Extraction différée ou sous conditions particulières après concertation pluridisciplinaire.



Piège Clinique (Examens) : Une dent de sagesse incluse asymptomatique ou une dent fonctionnelle cariée récupérable sont des contre-indications formelles [Ref: Q14 (2021 EMD), Q11 (2024 EMD)].

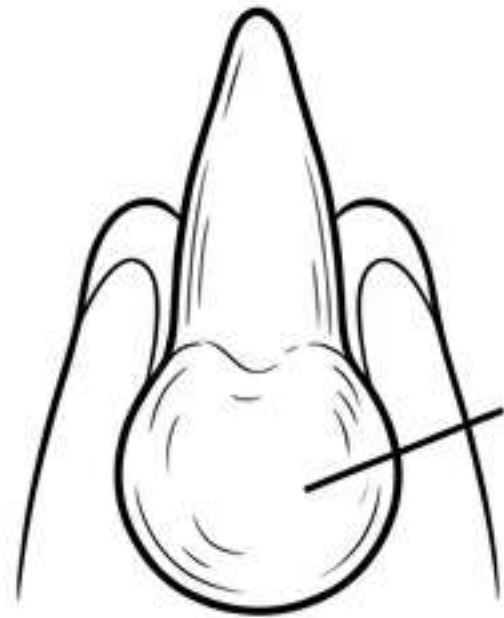
VI. Facteurs de Difficulté Liés à l'Extraction

Facteurs Anatomiques : Dents isolées sur l'arcade. Dents sans septum interdentaire.

Facteurs Structurels : Dents délabrées. Dents fracturées ou fragilisées.

Facteurs Mécaniques/Patient : Motifs prothétiques compliquant la prise d'appui. Patients bruxomanes.

Spécificité Épidémiologique :
Dents du sud algérien (hyper-cémentose, racines volumineuses)
[Predicted – Haute probabilité de question d'ancrage local]

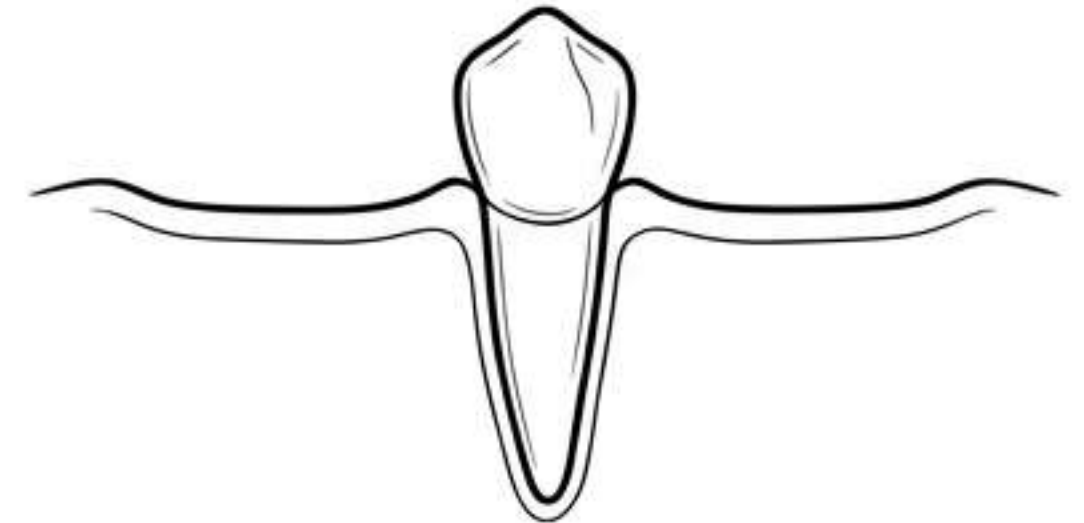


Dents du sud algérien :
Hyper-cémentose

Dents aeno toutique



Dents délabrées / fracturées

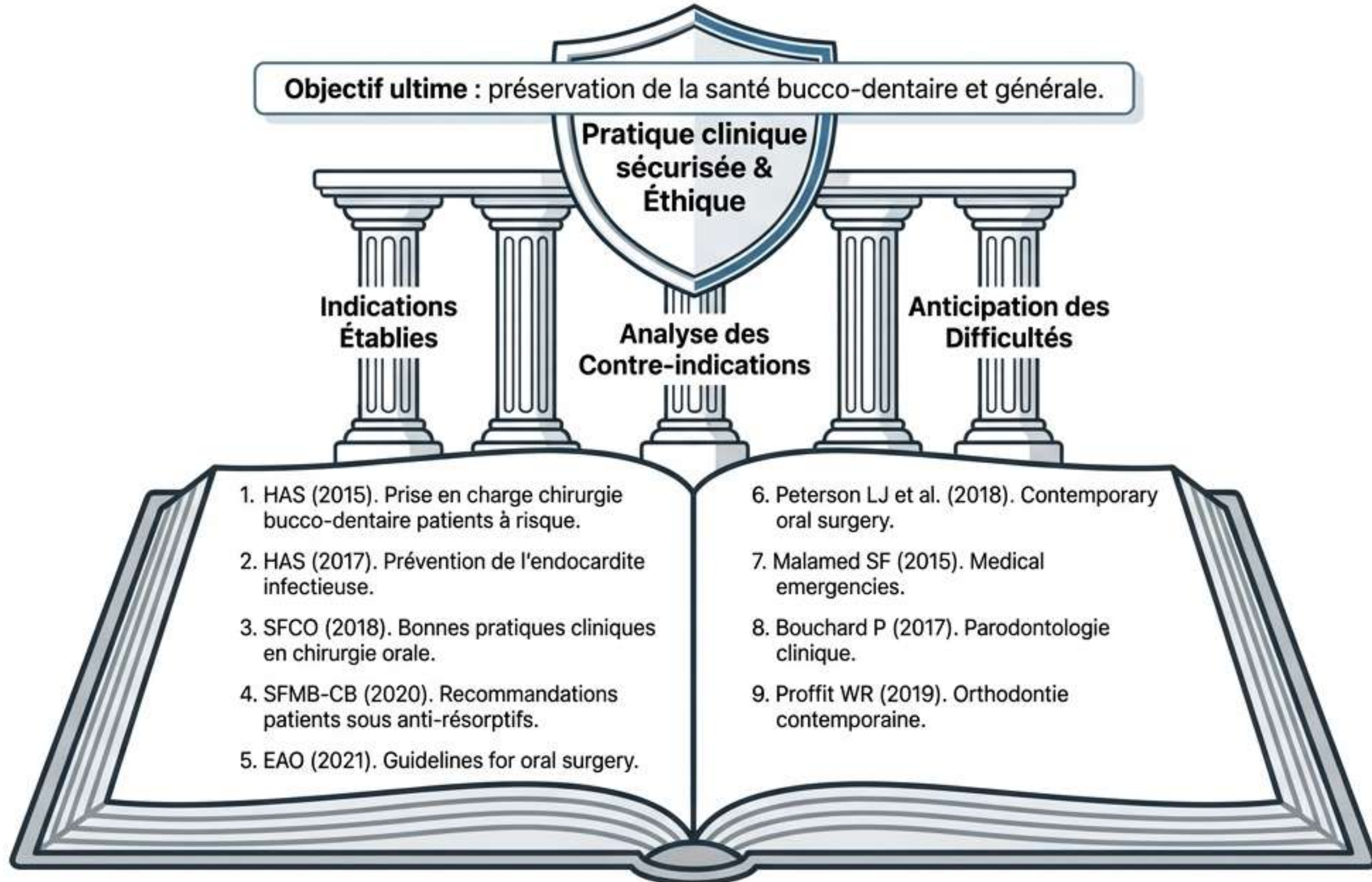


Dent isolée / sans septum

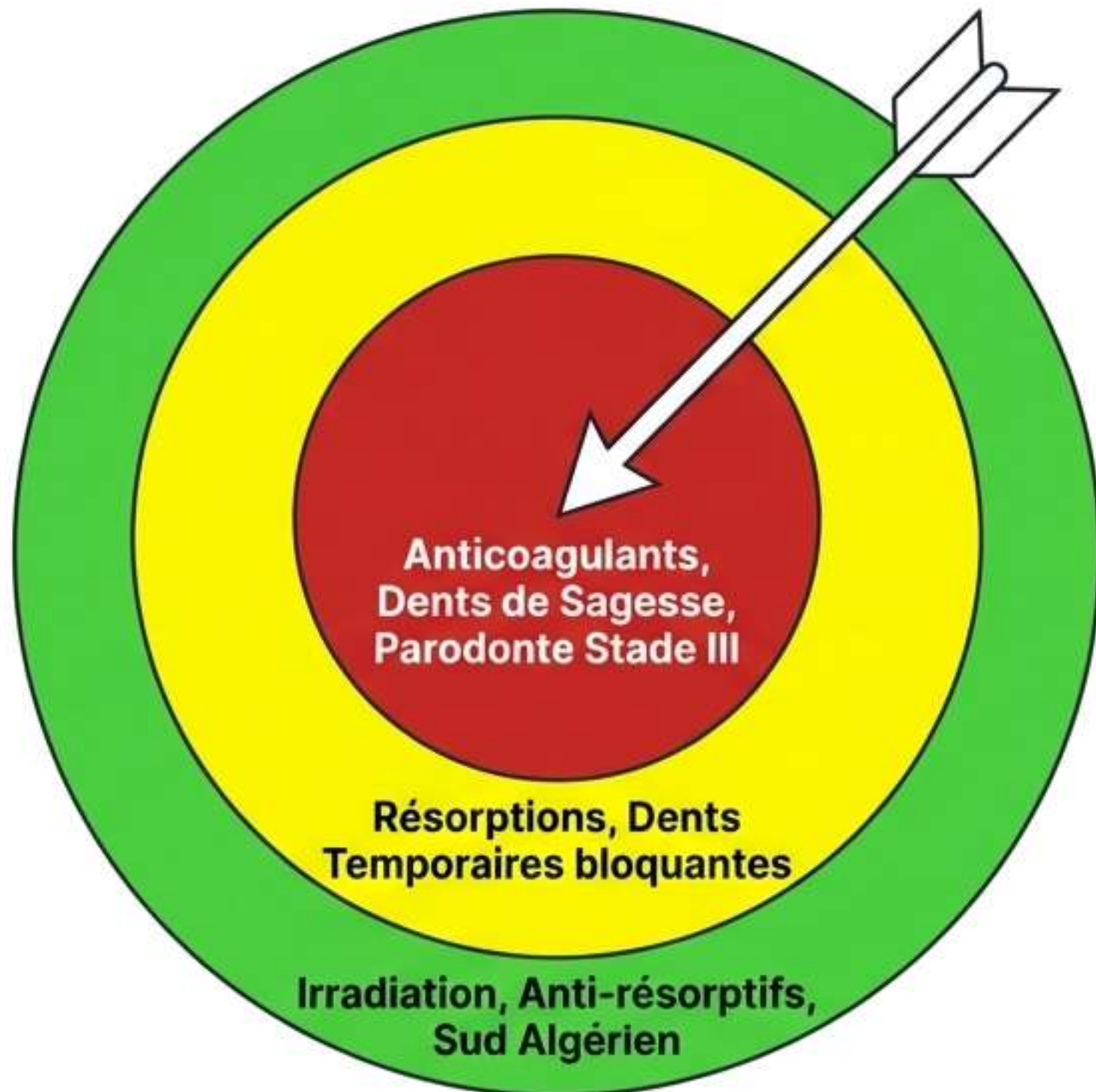


Conséquences (Risques) : Fracture radiculaire, perte osseuse, complications post-opératoires.

VII. Conclusion et Références Bibliographiques



Analyse Stratégique des Schémas d'Examen (Pattern Analysis)



Sujets les plus répétés (Très Haute Probabilité)

- **Hémostase** (Évaluation du risque hémorragique / Anticoagulants)
- **Dents de Sagesse** (Différencier incluse asymptomatique = CI vs. enclavée infectée = Indication)
- **Parodonte** (Mobilité III, Furcation III)
- **Cibles Futures** : Patients irradiés, Anti-résorptifs (ostéonécrose)

Zones de Pièges (Traps)



La carie simple : Une dent 'fonctionnelle cariée' n'est PAS une indication d'avulsion, il faut un échec thérapeutique.

Grossesse : Piège externe d'un QCM 2019 (préférable d'attendre l'accouchement).

Carte Mentale Synthétique : Le Dossier d'Avulsion

